المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم
الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف
الابتدائية السابعة والستون

وزارة التعليم
Ministry of Education

التوجيه والإرشاد الطلابي · دراسات حالة

ملف البحوث التشخيصية لدراسة الحالات الطلابية

سبعة بحوث تشخيصية متكاملة لأبرز مشكلات متعلمي المرحلة الابتدائية من البنين والبنات

غياب أحد الوالدين · ضعف القراءة والكتابة · السلوك العدواني والتنمر · الانطواء والخجل
التأخر والغياب المتكرر · تشتت الانتباه وفرط الحركة · الإفراط في الأجهزة الذكية

الابتدائية السابعة والستون

الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

مديرة المدرسة: **ناديه عوض الصخيري**

العام الدراسي **1448هـ** · تاريخ الإصدار **9/5/1448هـ**

وثيقة مهنية سرية · جميع الأسماء الواردة رمزية حفاظاً على خصوصية المتعلمين وأسرهم



بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا ﴾

سورة طه – الآية 114



المقدمة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فإن العناية بالمتعلم بوصفه محور العملية التعليمية لا تقتصر على الجانب المعرفي وحده، بل تمتد لتشمل نموه النفسي والاجتماعي والسلوكي والصحي؛ إذ لا يمكن لمتعلم يعاني من اضطراب في أي من هذه الجوانب أن يحقق أقصى ما تسمح به قدراته. ومن هنا تبرز أهمية البحث التشخيصي (دراسة الحالة) أداةً مهنيةً تمكّن المدرسة من فهم المشكلة فهماً عميقاً قبل التدخل فيها، والانتقال من ردود الأفعال الآنية إلى المعالجة المبنية على الشواهد والبيانات.

وانطلاقاً من رؤية المملكة العربية السعودية 2030 التي جعلت بناء الإنسان في مقدمة أولوياتها، وتماشياً مع توجهات وزارة التعليم في تعزيز الصحة النفسية والانضباط المدرسي ورفع جودة نواتج التعلم، حرصت الابتدائية السابعة والستون بالطائف على توثيق عدد من البحوث التشخيصية لحالات واقعية الطابع تمثّل أبرز المشكلات التي يواجهها متعلمو المرحلة الابتدائية من البنين والبنات.

ويضم هذا الملف سبعة بحوث تشخيصية متكاملة، يتناول كل منها مشكلة محددة وفق منهجية علمية موحدة تبدأ بجمع البيانات، مروراً بتحليل الأسباب وصياغة التشخيص، وانتهاءً ببناء خطة علاجية قابلة للقياس ومتابعتها وتقويم أثرها. وقد رُوعي في جميع الحالات استخدام أسماء رمزية حفاظاً على سرية المعلومات وخصوصية الأسر.

نسأل الله أن يكون هذا العمل لبنةً في بناء بيئة مدرسية آمنة ومحفّزة، وأن ينفع به أبناءنا وبناتنا، وأن يكون مرجعاً عملياً لمنسوبات المدرسة في التعامل المهني مع الحالات الطلابية.

والله ولي التوفيق ،،،
مديرة المدرسة: ناديه عوض الصخيري

فهرس المحتويات

المقدمة	3
الإطار النظري للبحث التشخيصي	5
ملخص الحالات المدروسة	7
1 الحالة الأولى: غياب أحد الوالدين وأثره على التحصيل والاستقرار النفسي	8
2 الحالة الثانية: ضعف مهارات القراءة والكتابة	11
3 الحالة الثالثة: السلوك العدواني والتنمر على الزملاء	14
4 الحالة الرابعة: الانطواء والخجل الاجتماعي	17
5 الحالة الخامسة: التأخر الصباحي والغياب المتكرر	20
6 الحالة السادسة: تشتت الانتباه وفرط الحركة	23
7 الحالة السابعة: الإفراط في استخدام الأجهزة الذكية	26
الخاتمة والتوصيات العامة	29
المرجعية واعتماد الملف	30

الإطار النظري للبحث التشخيصي

1 مفهوم البحث التشخيصي

البحث التشخيصي (دراسة الحالة) منهج علمي منظم يهدف إلى جمع المعلومات الشاملة عن متعلم يعاني من مشكلة دراسية أو سلوكية أو نفسية أو اجتماعية، وتحليلها تحليلاً دقيقاً للوصول إلى الأسباب الحقيقية الكامنة وراءها، ثم وضع خطة علاجية مناسبة ومتابعة تنفيذها وتقويم نتائجها.

2 أهداف البحث التشخيصي

- تحديد المشكلة تحديداً دقيقاً وقياس حجمها ومدى تكرارها وتأثيرها.
- الكشف عن الأسباب الذاتية والأسرية والمدرسية والاجتماعية المؤدية إليها.
- بناء خطة علاجية فردية واقعية قابلة للتنفيذ والقياس.
- توحيد جهود المدرسة والأسرة والجهات المساندة حول المتعلم.
- الوقاية من تفاقم المشكلة واكتشاف الحالات المشابهة مبكراً.
- توثيق الممارسات المهنية وتكوين قاعدة معرفية تفيد في الحالات المستقبلية.

3 خطوات البحث التشخيصي

1. **الرصد والإحالة:** ملاحظة المشكلة من قبل المعلمة أو ولي الأمر أو الإدارة، وإحالة الحالة رسمياً إلى الموجهة الطلابية.
2. **جمع البيانات:** استخدام أدوات متعددة: المقابلة، الملاحظة، السجلات، الاختبارات التشخيصية، الاستبانات، وتقارير المعلمات.
3. **تحليل الأسباب:** تصنيف العوامل المؤثرة إلى ذاتية وأسرية ومدرسية واجتماعية، وتحديد السبب الرئيس والأسباب المساعدة.
4. **صياغة التشخيص:** صياغة عبارة تشخيصية موجزة ودقيقة تصف المشكلة وأسبابها المرجّحة.
5. **بناء الخطة العلاجية:** تحديد أهداف قابلة للقياس وإجراءات ومسؤوليات وجداول زمنية ومؤشرات نجاح.
6. **التنفيذ والمتابعة:** تطبيق الخطة ومتابعتها دورياً وتوثيق التقدم أسبوعاً بأسبوع.

7 **التقويم والإغلاق:** قياس أثر التدخل ومقارنته بخط الأساس، ثم إغلاق الحالة أو تعديل الخطة أو الإحالة لجهة متخصصة.

4 أدوات جمع المعلومات

الأداة	الاستخدام
المقابلة	فردية مع المتعلم، ومع ولي الأمر، ومع المعلمات ذوات العلاقة.
الملاحظة المنظمة	رصد السلوك في مواقف محددة باستخدام بطاقات ملاحظة ذات تكرارات وأوقات.
السجلات المدرسية	سجلات الحضور والغياب، والتحصيل، والسلوك، والملف الصحي.
الاختبارات التشخيصية	اختبارات المهارات الأساسية وقياس الفاقد التعليمي.
المقاييس والاستبانات	مقاييس مقننة مناسبة للمرحلة العمرية تطبّقها الجهة المختصة.
الرسم والتعبير الحر	أدوات إسقاطية مساعدة تكشف المشاعر لدى الأطفال الصغار.

5 الضوابط الأخلاقية والمهنية

- السرية التامة لمعلومات الحالة، وحفظ الملف لدى الموجهة الطلابية فقط.
- استخدام الأسماء الرمزية في أي توثيق أو عرض.
- الحصول على موافقة ولي الأمر قبل تطبيق المقاييس أو الإحالة الخارجية.
- احترام كرامة المتعلم وتجنب الوصم أو المقارنة أمام الآخرين.
- عدم إصدار أحكام طبية أو نفسية، والإحالة للجهة المختصة عند الحاجة.
- العمل بروح الفريق مع إطلاع كل طرف على ما يخصه فقط.

ملخص الحالات المدروسة

يعرض الجدول التالي ملخصاً للحالات السبع التي تناولها الملف، وقد رُوعي في اختيارها أن تغطي المجالات النفسية والاجتماعية والتعليمية والسلوكية والانضباطية والصحية، وأن تشمل البنين في صفوف الطفولة المبكرة والبنات في مختلف صفوف المرحلة.

م	المشكلة	الحالة	الصف	المجال
1	غياب أحد الوالدين وأثره على التحصيل والاستقرار النفسي	الطالبة (ر)	الرابع الابتدائي	نفسي – اجتماعي
2	ضعف مهارات القراءة والكتابة	الطالب (م)	الثالث الابتدائي (الطفولة المبكرة)	تعليمي – تحصيلي
3	السلوك العدواني والتنمر على الزملاء	الطالب (ع)	الثالث الابتدائي (الطفولة المبكرة)	سلوكي
4	الانطواء والخجل الاجتماعي	الطالبة (ن)	الثاني الابتدائي	نفسي – اجتماعي
5	التأخر الصباحي والغياب المتكرر	الطالبة (ه)	السادس الابتدائي	انضباطي – أسري
6	تشتت الانتباه وفرط الحركة	الطالب (ف)	الأول الابتدائي (الطفولة المبكرة)	سلوكي – تعليمي
7	الإفراط في استخدام الأجهزة الذكية	الطالبة (ج)	الخامس الابتدائي	سلوكي – صحي

المنهجية الموحدة لعرض كل حالة

- بيانات الحالة الأساسية (بأسماء رمزية).
- وصف المشكلة ومظاهرها السلوكية القابلة للملاحظة.
- أدوات التشخيص المستخدمة ونتائج كل أداة.
- تحليل الأسباب: ذاتية – أسرية – مدرسية.
- العبارة التشخيصية.
- الخطة العلاجية: الهدف، الإجراء، المسؤول، المدة، مؤشر النجاح.
- المتابعة والتقويم الأسبوعي.
- التوصيات والاعتماد.

البحث التشخيصي – الحالة الأولى

1 غياب أحد الوالدين وأثره على التحصيل والاستقرار النفسي

المجال: **نفسي – اجتماعي** | العام الدراسي: **1448هـ** | مستوى السرية: **سري**

1 بيانات الحالة

الاسم الرمزي **الطالبة (ر)**	الصف **الرابع الابتدائي**	العمر **9 سنوات**
ترتيبها بين إخوتها **الثانية من ثلاثة**	جهة الإحالة **معلمة الصف ورائدة الفصل**	تاريخ الإحالة **الأسبوع الثالث من الفصل الدراسي الأول 1448هـ**

2 وصف المشكلة

لوحظ على الطالبة (ر) منذ بداية العام الدراسي تراجع ملحوظ في مستواها الدراسي بعد أن كانت من المتفوقات في الأعوام السابقة، مصحوباً بميل إلى العزلة وشرود الذهن والبكاء دون سبب ظاهر أثناء الحصص. وبالرجوع إلى ملفها وبمقابلة ولية أمرها تبيّن أن والدها توفي قبل نحو ثمانية أشهر، وأن الأسرة انتقلت للسكن مع الجدة، وأن الأم انشغلت بأعباء العمل ورعاية الأسرة منفردة.

المظاهر السلوكية الملاحظة:

- انخفاض المعدل التحصيلي من (ممتاز) إلى (جيد) في الرياضيات والعلوم خلال فترة وجيزة.
- شرود الذهن وضعف التركيز وعدم إكمال الواجبات الصفية والمنزلية.
- العزلة عن الزميلات وتجنّب الأنشطة الجماعية والإذاعة المدرسية التي كانت تشارك فيها.
- نوبات بكاء متكررة خاصة في حصص التعبير وعند الحديث عن الأسرة.
- شكاوى جسدية متكررة (صداع، ألم بطن) دون سبب عضوي واضح، وطلب الاتصال بالأم.

3 أدوات التشخيص وجمع المعلومات

الأداة	الإجراء المنفّذ	أبرز النتائج
مقابلة الطالبة	ثلاث جلسات فردية بأسلوب الحوار الداعم والرسم الحر	مشاعر حزن وخوف من فقدان الأم، وإحساس بأن البيت تغيّر
مقابلة ولية الأمر	جلستان (حضوري وهاتفي)	تأكيد ظروف الفقد والانتقال، وضيق وقت الأم وقلقها على ابنتها
تقارير المعلمات	استمارة رصد من معلمات الرياضيات والعلوم ولغتي	تراجع المشاركة والتركيز، وتذبذب أداء الواجبات

الأداة	الإجراء المنفّذ	أبرز النتائج
السجلات المدرسية	مراجعة درجات العامين السابقين والحضور	انخفاض واضح بعد الفقد، وغياب متقطع (6 أيام)
الملاحظة المنظمة	بطاقة ملاحظة لمدة أسبوعين في الفصل والفسحة	انعزال في 80% من فترات الفسحة
الملف الصحي	مراجعة مع المرشدة الصحية	لا توجد أمراض عضوية مسجلة

4 تحليل أسباب المشكلة

عوامل ذاتية

- مشاعر الحزن والفقد غير المعبَّر عنها بصورة صحية.
- قلق الانفصال والخوف من فقدان الأم.
- انخفاض تقدير الذات وفقدان الدافعية.

عوامل أسرية

- غياب الأب وما ترتب عليه من فراغ عاطفي وتربوي.
- انشغال الأم وقلة الوقت المخصص للمتابعة.
- تغيّر بيئة السكن والروتين اليومي.

عوامل مدرسية

- عدم إبلاغ المدرسة بظروف الفقد في حينه.
- تركيز بعض المواقف الصفية على موضوعات الأسرة والأب دون مراعاة.
- قلة الأنشطة الداعمة نفسياً في الفصل.

5 التشخيص

العبارة التشخيصية

تعاني الطالبة (ر) من تراجع تحصيلي واضطراب انفعالي مؤقت (حزن وقلق انفصال) ناتج عن فقدان الوالد وتغيّر الظروف الأسرية، مع ضعف قنوات الدعم العاطفي في البيت والمدرسة، ولا تشير المعطيات إلى صعوبة تعلم أساسية.

6 الخطة العلاجية

الهدف	الإجراءات	المسؤول	المدة	مؤشر النجاح
تهيئة بيئة صفية آمنة ومتفهمة	إطلاع المعلمات ذوات العلاقة بسرية على ظروف الطالبة، ومراعاة الموضوعات الحساسة في الحصص	الموجهة الطلابية والمعلمات	الأسبوع الأول	توقف نوبات البكاء داخل الحصص
تفريغ المشاعر وتقبّل الفقد	جلسات إرشاد فردي أسبوعية باستخدام الرسم والقصة العلاجية والحوار الداعم	الموجهة الطلابية	8 أسابيع	تعبير الطالبة عن مشاعرها لفظياً بصورة متزنة
إعادة الاندماج الاجتماعي	إشراكها في مجموعة تعاونية صغيرة، وتكليفها بمهمة محببة (مساعدة أمينة المكتبة / الإذاعة)	رائدة الفصل	6 أسابيع	مشاركتها في الأنشطة الجماعية مرتين أسبوعياً على الأقل
استعادة المستوى التحصيلي	خطة علاجية في الرياضيات والعلوم بأوراق عمل متدرجة وتعزيز فوري	معلمات المواد	فصل دراسي	رفع درجات الاختبارات القصيرة بنسبة 20% على الأقل

الهدف	الإجراءات	المسؤول	المدة	مؤشر النجاح
تفعيل الشراكة مع الأسرة	لقاء إرشادي مع الأم حول التعامل مع حزن الطفل، وتخصيص وقت يومي قصير للحوار	الموجهة الطلابية وولية الأمر	شهرياً	تقرير الأم عن تحسّن تواصل ابنتها في البيت
الدعم القيمي والإيماني	تعزيز معاني الصبر والرضا بأسلوب مناسب لعمرها، وتذكيرها بالدعاء للوالد	معلمة الدراسات الإسلامية	مستمر	ارتفاع مؤشرات الطمأنينة في جلسات الإرشاد

7 المتابعة والتقويم

الفترة	ما تم تنفيذه	النتيجة المتحققة
الأسبوع 1 إلى 2	بدء الجلسات وتهيئة المعلمات	انخفاض نوبات البكاء من يومية إلى مرتين أسبوعياً
الأسبوع 3 إلى 4	دمج الطالبة في المجموعة التعاونية	مشاركة أولى في نشاط الإذاعة
الأسبوع 5 إلى 6	متابعة الخطة العلاجية للمواد	تحسن درجات الاختبارات القصيرة
الأسبوع 7 إلى 8	تقويم شامل ولقاء ثانٍ مع الأم	استقرار انفعالي وعودة تدريجية للمستوى السابق

8 التوصيات

- إلزام أولياء الأمور عبر نموذج رسمي بإبلاغ المدرسة بالظروف الأسرية الطارئة (وفاة، انفصال، سفر طويل) بسرية تامة.
- إعداد قائمة سرية بالطالبات اللواتي يعشن غياب أحد الوالدين ومتابعتهن متابعة وقائية.
- تدريب المعلمات على مهارات التعامل مع الطفل الحزين وتجنب الموضوعات المؤلمة دون تمهيد.
- تنفيذ برنامج جماعي بعنوان (أمانٌ وطمأنينة) للطالبات في الظروف المشابهة.
- الإحالة إلى أخصائية نفسية بموافقة الأم إذا استمرت الأعراض بعد انتهاء الخطة.

الموجهة الطلابية
هند العتيبي

رائدة الفصل
نجلاء الصخيري

مديرة المدرسة
ناديه عوض الصخيري

البحث التشخيصي – الحالة الثانية

2 ضعف مهارات القراءة والكتابة

المجال: **تعليمي – تحصيلي** | العام الدراسي: **1448هـ** | مستوى السرية: **سري**

1 بيانات الحالة

الاسم الرمزي	الصف	العمر
الطالب (م)	**الثالث الابتدائي (الطفولة المبكرة)**	**8 سنوات**
ترتيبه بين إخوته	جهة الإحالة	تاريخ الإحالة
الأخير من خمسة	**معلمة لغتي**	**بعد نتائج الاختبار التشخيصي القبلي 1448هـ**

2 وصف المشكلة

أظهرت نتائج الاختبار التشخيصي القبلي في مادة لغتي أن الطالب (م) لم يتقن المهارات القرائية والكتابية المتوقعة لصفه؛ إذ يقرأ ببطء شديد بأسلوب التهجئة الحرفية، ويخلط بين الحروف المتشابهة رسماً وصوتاً، ويعجز عن كتابة كلمات بسيطة إملائياً، مما انعكس سلباً على تحصيله في بقية المواد التي تعتمد على القراءة.

المظاهر السلوكية الملاحظة:

- قراءة متقطعة بالتهجئة لا تتجاوز (12) كلمة في الدقيقة، والمتوقع لصفه (40 إلى 60) كلمة.
- الخلط بين الحروف المتشابهة (ب – ت – ث) و(ح – خ – ج) و(س – ص).
- حذف المدود وإبدال الحركات القصيرة بالطويلة والعكس.
- كتابة غير مقروءة مع عكس اتجاه بعض الحروف.
- تجنّب القراءة الجهرية والشعور بالخجل، والانسحاب من المشاركة في الحصة.

3 أدوات التشخيص وجمع المعلومات

الأداة	الإجراء المنفّذ	أبرز النتائج
الاختبار التشخيصي	اختبار مهارات القراءة والكتابة للصف الثالث	إتقان 35% فقط من المهارات الأساسية
قياس الطلاقة القرائية	قراءة نص قصير مع حساب عدد الكلمات الصحيحة في الدقيقة	12 كلمة/دقيقة بدقة 60%
تحليل الأخطاء الكتابية	تحليل كراسة الإملاء والتعبير لشهر كامل	أخطاء متكررة في الحروف المتشابهة والمدود
مقابلة ولي الأمر	لقاء حضوري مع الأم	ضعف القراءة منذ الصف الأول، وقلة المتابعة المنزلية

الأداة	الإجراء المنفّذ	أبرز النتائج
الفحص الصحي	فحص النظر والسمع عبر المرشدة الصحية	حاجة لفحص نظر تفصيلي – أُحيل للمركز الصحي
ملاحظة الأداء	ملاحظة الطالب في حصص لغتي والرياضيات	يفهم المسائل شفهياً ويعجز عند قراءتها

4 تحليل أسباب المشكلة

عوامل ذاتية	عوامل أسرية	عوامل مدرسية
• فاقد تعليمي متراكم في المهارات الأساسية منذ الصف الأول. • ضعف الوعي الصوتي والتمييز السمعي بين الأصوات. • انخفاض الثقة بالنفس عند القراءة.	• انشغال الأسرة وغياب جلسات القراءة المنزلية. • عدم توفر قصص وكتب مناسبة لعمره في البيت. • الإفراط في استخدام الأجهزة على حساب القراءة.	• عدم اكتشاف الضعف مبكراً ومعالجته في الصفوف الأولى. • كثافة الفصل وقلة الوقت المخصص للعلاج الفردي. • اعتماد التقويم على الكتابة أكثر من الأداء الشفهي.

5 التشخيص

العبارة التشخيصية

يعاني الطالب (م) من ضعف قرائي وكتابي ناتج عن فاقد تعليمي متراكم في مهارات الوعي الصوتي وربط الصوت بالرمز، مع احتمال وجود ضعف بصري يستدعي الفحص، ولا يمكن الجزم بصعوبة تعلم نمائية إلا بعد تطبيق برنامج علاجي مكثف وإعادة القياس.

6 الخطة العلاجية

الهدف	الإجراءات	المسؤول	المدة	مؤشر النجاح
التأكد من سلامة الحواس	إحالة لفحص النظر التفصيلي ومتابعة النتيجة مع الأسرة	المرشدة الصحية	أسبوعان	استلام تقرير الفحص وتنفيذ توصياته
تنمية الوعي الصوتي	تمارين يومية (10 دقائق) لتمييز الأصوات والمقاطع باستخدام البطاقات والألعاب اللغوية	معلمة لغتي	4 أسابيع	تمييز 90% من الحروف المتشابهة صوتياً
ربط الصوت بالرمز	برنامج (الحرف في الكلمة) بالبطاقات الملونة والكتابة على الرمل والسبورة الصغيرة	معلمة لغتي	6 أسابيع	كتابة كلمات ثلاثية وثنائية المقطع بدقة 80%
رفع الطلاقة القرائية	القراءة المتكررة لنصوص قصيرة، والقراءة المزدوجة مع زميل متمكن	معلمة لغتي ورائدة الفصل	8 أسابيع	الوصول إلى 35 كلمة/دقيقة
تعزيز الثقة والدافعية	لوحة إنجاز فردية ونجوم تقدم، وقراءته أمام مجموعة صغيرة قبل الفصل كاملاً	معلمة لغتي	مستمر	مبادرته بالقراءة الجهرية طوعاً

الهدف	الإجراءات	المسؤول	المدة	مؤشر النجاح
إشراك الأسرة	حقيبة قراءة منزلية أسبوعية وجدول متابعة يوقّعه ولي الأمر	الموجهة الطلابية وولي الأمر	أسبوعياً	انتظام توقيع الجدول بنسبة 80%

7 المتابعة والتقويم

الفترة	ما تم تنفيذه	النتيجة المتحققة
الأسبوع 1 إلى 2	الفحص الصحي وتمارين الوعي الصوتي	تقرير النظر: يحتاج نظارة طبية – تم توفيرها
الأسبوع 3 إلى 4	برنامج ربط الصوت بالرمز	تحسّن تمييز الحروف المتشابهة إلى 75%
الأسبوع 5 إلى 6	القراءة المتكررة والمزدوجة	ارتفاع الطلاقة إلى 25 كلمة/دقيقة
الأسبوع 7 إلى 8	إعادة الاختبار التشخيصي	إتقان 65% من المهارات مقارنة بـ 35% في خط الأساس

8 التوصيات

- تطبيق الاختبار التشخيصي في المهارات الأساسية لجميع طلاب وطالبات الصفوف الأولية في الأسبوعين الأولين.
- تخصيص حصص علاجية أسبوعية ضمن مجموعات صغيرة متجانسة المستوى.
- الفحص الدوري للنظر والسمع لكل طالب يظهر ضعفاً قرائياً قبل بدء العلاج.
- تفعيل مبادرة (حقيبة القراءة المنزلية) وإشراك الأسر في برنامج القراءة.
- إحالة الحالة لمعلمة صعوبات التعلم إذا لم يتحقق التقدم المتوقع بعد إعادة القياس.

الموجهة الطلابية
هند العتيبي

رائدة الفصل
عزة الزهراني

مديرة المدرسة
ناديه عوض الصخيري

البحث التشخيصي – الحالة الثالثة

3 السلوك العدواني والتنمر على الزملاء

المجال: **سلوكي** | العام الدراسي: **1448هـ** | مستوى السرية: **سري**

1 بيانات الحالة

الاسم الرمزي	الصف	العمر
الطالب (ع)	**الثالث الابتدائي (الطفولة المبكرة)**	**9 سنوات**
ترتيبه بين إخوته	جهة الإحالة	تاريخ الإحالة
الأكبر من أربعة	**وكيلة الشؤون التعليمية وعدد من أولياء الأمور**	**الأسبوع الخامس من الفصل الدراسي الأول 1448هـ**

2 وصف المشكلة

تكررت الشكاوى من زملاء الطالب (ع) وأولياء أمورهم بسبب اعتدائه عليهم بالضرب والدفع وأخذ أدواتهم بالقوة، إضافة إلى السخرية من بعضهم وإطلاق ألقاب جارحة عليهم، وتركّز ذلك في أوقات الفسحة والانصراف وحصص النشاط. وقد سُجلت عليه عدة مخالفات سلوكية في سجل السلوك خلال شهر واحد.

المظاهر السلوكية الملاحظة:

- الاعتداء الجسدي على الزملاء (ضرب، دفع، عرقلة) بمعدل 3 إلى 4 مرات أسبوعياً.
- التنمر اللفظي: السخرية والألقاب الجارحة والتهديد.
- أخذ أدوات الزملاء ووجباتهم دون إذن.
- عدم الالتزام بتوجيهات المعلمات والرد عليهن بانفعال.
- التفاخر بالقوة وتشكيل مجموعة صغيرة من الزملاء يقودها في الفسحة.

3 أدوات التشخيص وجمع المعلومات

الأداة	الإجراء المنفّذ	أبرز النتائج
سجل السلوك	مراجعة المخالفات المسجلة خلال الشهر	7 مخالفات من الدرجة الثانية والثالثة
الملاحظة المنظمة	بطاقة رصد تكرار السلوك وتوقيته ومثيراته لمدة أسبوعين	75% من الحوادث في الفسحة والانصراف
مقابلة الطالب	جلستان فرديتان	يرى أن الضرب وسيلة لـ(أخذ الحق) وكسب الاحترام
مقابلة ولي الأمر	لقاء حضوري مع الأب	أسلوب تربية يعتمد على العقاب البدني، ومشاهدة ألعاب عنيفة

الأداة	الإجراء المنفّذ	أبرز النتائج
استطلاع الزملاء	أسئلة بسيطة سرية لعينة من زملاء الفصل	شعور عدد من الزملاء بالخوف منه
تقارير المعلمات	استمارة رصد من 4 معلمات	سلوك أهدأ في الحصص المنظمة والمحفزة

4 تحليل أسباب المشكلة

عوامل ذاتية

- ضعف مهارات ضبط الانفعال وحل المشكلات.
- الرغبة في لفت الانتباه وإثبات الذات.
- طاقة حركية عالية غير موجّهة.

عوامل أسرية

- الاعتماد على العقاب البدني أسلوباً تربوياً.
- مشاهدة الألعاب والمقاطع العنيفة دون رقابة.
- تحميله مسؤولية إخوته الصغار بأسلوب السيطرة.

عوامل مدرسية

- قلة الإشراف في بعض مواقع الفسحة والانصراف.
- عدم وجود أنشطة تفرّغ الطاقة في أوقات الفراغ.
- تأخر الحزم في تطبيق الإجراءات السلوكية المتدرجة.

5 التشخيص

العبارة التشخيصية

يعاني الطالب (ع) من سلوك عدواني وتنمر متكرر ناتج عن نمذجة أساليب عنيفة في البيئة الأسرية والإعلامية، وضعف مهارات ضبط الانفعال، مع ثغرات في الإشراف المدرسي أثناء أوقات الفراغ؛ وهو سلوك مكتسب قابل للتعديل.

6 الخطة العلاجية

الهدف	الإجراءات	المسؤول	المدة	مؤشر النجاح
حماية الزملاء وضبط البيئة	تكثيف الإشراف في الفسحة والانصراف وتحديد مواقع آمنة، وتطبيق الإجراءات المتدرجة وفق قواعد السلوك والمواظبة	الوكيلة والمشرفات	فوري ومستمر	انخفاض الحوادث المسجلة بنسبة 50% خلال شهر
تعليم ضبط الانفعال	تدريب على أسلوب (توقّف – تنفّس – فكّر – تصرّف) عبر لعب الأدوار والقصص	الموجهة الطلابية	6 جلسات	استخدامه الأسلوب في موقفين موثقين
تعديل السلوك بالعقد السلوكي	عقد سلوكي مكتوب بين الطالب والموجهة وولي الأمر بأهداف يومية ومكافآت متفق عليها	الموجهة الطلابية	8 أسابيع	تحقيق أهداف العقد 4 أيام من 5
توجيه الطاقة إيجابياً	إسناد دور قيادي إيجابي (قائد فريق النظام / مساعد معلمة التربية البدنية)	معلمة التربية البدنية	فصل دراسي	التزامه بالدور دون مخالفات
بناء التعاطف وإصلاح العلاقة	جلسة إصلاحية مع الزملاء المتضررين بإشراف الموجهة، وتكليفه بعمل تعاوني معهم	الموجهة الطلابية	أسبوعان	اعتذار الطالب وتحسن علاقته بزملائه

الهدف	الإجراءات	المسؤول	المدة	مؤشر النجاح
الشراكة الأسرية	توعية ولي الأمر ببدائل العقاب البدني، وتنظيم وقت الأجهزة والمحتوى المشاهد	الموجهة وولي الأمر	لقاءان	التزام الأسرة ببطاقة المتابعة المنزلية

7 المتابعة والتقويم

الفترة	ما تم تنفيذه	النتيجة المتحققة
الأسبوع 1 إلى 2	ضبط الإشراف وتوقيع العقد السلوكي	انخفاض الاعتداء الجسدي إلى مرة واحدة أسبوعياً
الأسبوع 3 إلى 4	جلسات ضبط الانفعال والدور القيادي	لم تُسجل حوادث تنمر لفظي
الأسبوع 5 إلى 6	الجلسة الإصلاحية والعمل التعاوني	تحسن ملحوظ في علاقته بزملائه
الأسبوع 7 إلى 8	تقويم العقد ولقاء ولي الأمر	تحقيق أهداف العقد بنسبة 85%

8 التوصيات

- تنفيذ برنامج وقائي مدرسي لمكافحة التنمر يشمل جميع الصفوف وأسبوعاً توعوياً سنوياً.
- إعداد خريطة إشراف للمواقع الحرجة في الفسحة والانصراف ومراجعتها شهرياً.
- توفير أنشطة حركية منظمة أثناء الفسحة لتفريغ الطاقة.
- تفعيل صندوق سري للإبلاغ عن التنمر يتابعه فريق التوجيه.
- الإحالة لوحدة الخدمات الإرشادية إذا عاد السلوك بعد إغلاق الحالة.

الموجهة الطلابية
هند العتيبي

رائدة الفصل
غزيل العتيبي

مديرة المدرسة
ناديه عوض الصخيري

4

البحث التشخيصي – الحالة الرابعة

الانطواء والخجل الاجتماعي

المجال: **نفسي – اجتماعي** | العام الدراسي: **1448هـ** | مستوى السرية: **سري**

1 بيانات الحالة

الاسم الرمزي	الصف	العمر
الطالبة (ن)	**الثاني الابتدائي**	**7 سنوات**
ترتيبها بين إخوتها	جهة الإحالة	تاريخ الإحالة
الوحيدة	**رائدة الفصل**	**الأسبوع الرابع من الفصل الدراسي الأول 1448هـ**

2 وصف المشكلة

تلاحظ رائدة الفصل أن الطالبة (ن) لا تتحدث داخل الفصل إلا نادراً وبصوت منخفض جداً، وتتجنب الإجابة الشفهية ولو كانت تعرف الإجابة، وتقضي وقت الفسحة منفردة قرب باب الفصل. وعلى الرغم من ذلك فإن أداءها الكتابي جيد، وتؤكد والدتها أنها تتحدث بطلاقة وحيوية في البيت.

المظاهر السلوكية الملاحظة:

- الصمت شبه التام في الفصل والإجابة بالإيماء أو الكتابة.
- احمرار الوجه وارتجاف الصوت عند توجيه سؤال مباشر إليها.
- قضاء الفسحة وحيدة وعدم وجود صديقة مقربة.
- رفض المشاركة في الإذاعة والأنشطة أمام الآخرين.
- أداء كتابي جيد يدل على فهم المحتوى وتمكّنها منه.

3 أدوات التشخيص وجمع المعلومات

الأداة	الإجراء المنفّذ	أبرز النتائج
الملاحظة المنظمة	رصد مرات المبادرة بالكلام والتفاعل لمدة أسبوعين	مبادرة واحدة فقط بالكلام خلال الأسبوعين
مقابلة الطالبة	جلسات فردية بالدمى والرسم واللعب	تتحدث بصوت أوضح في الجلسات الفردية بعد الألفة
مقابلة ولية الأمر	لقاء حضوري	طفلة وحيدة، قليلة الاختلاط بالأطفال، وحماية زائدة من الأسرة
تقارير المعلمات	استمارة رصد مختصرة	أداء كتابي جيد ومشاركة شفهية معدومة

الأداة	الإجراء المنفّذ	أبرز النتائج
الرسم الحر	رسم (أنا في المدرسة)	رسمت نفسها صغيرة جداً في زاوية الصفحة
السجلات المدرسية	الحضور والتحصيل	حضور منتظم وتحصيل كتابي جيد جداً

4 تحليل أسباب المشكلة

عوامل ذاتية

- طبع خجول وحساسية زائدة للتقييم.
- ضعف المهارات الاجتماعية والمبادرة.
- الخوف من الخطأ أمام الآخرين.

عوامل أسرية

- كونها الطفلة الوحيدة وقلة اختلاطها بالأقران.
- الحماية الزائدة وقيام الأسرة بالأدوار نيابة عنها.
- قلة الزيارات والأنشطة الاجتماعية خارج المنزل.

عوامل مدرسية

- التركيز على المشاركة الشفهية أمام الفصل كاملاً.
- قلة العمل في مجموعات صغيرة.
- تعليقات زميلات على صمتها أشعرتها بالحرج.

5 التشخيص

العبارة التشخيصية

تعاني الطالبة (ن) من خجل اجتماعي وانطواء في البيئة المدرسية، ناتج عن طبع حساس وقلة الخبرات الاجتماعية والحماية الزائدة، مع مواقف صفية ضاغطة؛ ويُرصد الصمت الانتقائي احتمالاً يستلزم المتابعة إذا استمر رغم التدخل.

6 الخطة العلاجية

الهدف	الإجراءات	المسؤول	المدة	مؤشر النجاح
بناء الألفة والأمان	جلسات فردية قصيرة باللعب والدمى، والتواصل اللطيف دون ضغط للكلام	الموجهة الطلابية	3 أسابيع	حديثها مع الموجهة بصوت مسموع
التدرج في المشاركة	سلّم تدريجي: إجابة كتابية ← همس للمعلمة ← إجابة لزميلة ← إجابة لمجموعة ← إجابة للفصل	رائدة الفصل	8 أسابيع	إجابة شفهية واحدة أمام الفصل أسبوعياً
تكوين صداقة داعمة	إقرانها بزميلة ودودة (الصديقة الرفيقة) في الفسحة والأنشطة	رائدة الفصل	6 أسابيع	قضاء الفسحة مع زميلة 4 أيام من 5
تنمية الثقة بالنفس	مهام قيادية بسيطة غير كلامية (توزيع الأوراق، مسؤولة الركن)، وإبراز إنجازاتها الكتابية	معلمات الفصل	مستمر	مبادرتها بطلب مهمة
ضبط البيئة الصفية	منع التعليقات على صمتها، وتعزيز ثقافة التقبل في الفصل	رائدة الفصل	فوري	عدم تكرار التعليقات السلبية

الهدف	الإجراءات	المسؤول	المدة	مؤشر النجاح
الشراكة الأسرية	توجيه الأسرة لتقليل الحماية الزائدة وإتاحة لقاءات منظمة مع أقرانها خارج المدرسة	الموجهة وولية الأمر	شهرياً	مشاركتها في نشاط اجتماعي خارجي

7 المتابعة والتقويم

الفترة	ما تم تنفيذه	النتيجة المتحققة
الأسبوع 1 إلى 2	جلسات الألفة الفردية	بدأت تتحدث مع الموجهة بصوت منخفض
الأسبوع 3 إلى 4	الصديقة الرفيقة والمهام غير الكلامية	قضاء الفسحة مع زميلتها الرفيقة
الأسبوع 5 إلى 6	التدرج في المشاركة	أجابت لمجموعتها الصغيرة شفهياً
الأسبوع 7 إلى 8	التقويم ولقاء الأسرة	أول إجابة شفهية أمام الفصل كاملاً

8 التوصيات

- تنويع أساليب المشاركة الصفية لتشمل الكتابة والعمل في مجموعات صغيرة وعدم حصرها في الإجابة الجهرية.
- تنفيذ برنامج (الصديقة الرفيقة) لدعم الطالبات الجدد والخجولات.
- تدريب المعلمات على التمييز بين الخجل الطبيعي والصمت الانتقائي.
- إشراك الطالبات الخجولات في أنشطة فنية وكتابية تبرز قدراتهن.
- الإحالة لأخصائية نفسية إذا استمر الصمت داخل المدرسة بعد فصل دراسي من التدخل.

الموجهة الطلابية
هند العتيبي

رائدة الفصل
هلا العتيبي

مديرة المدرسة
ناديه عوض الصخيري

5

البحث التشخيصي – الحالة الخامسة

التأخر الصباحي والغياب المتكرر

المجال: **انضباطي – أسري** | العام الدراسي: **1448هـ** | مستوى السرية: **سري**

1 بيانات الحالة

الاسم الرمزي	الصف	العمر
الطالبة (ه)	**السادس الابتدائي**	**12 سنة**
ترتيبها بين إخوتها	جهة الإحالة	تاريخ الإحالة
الكبرى من ستة	**وكيلة شؤون الطالبات**	**نهاية الشهر الأول من الفصل الدراسي الأول 1448هـ**

2 وصف المشكلة

أظهر نظام نور وسجل المتابعة اليومية تكرار تأخر الطالبة (ه) عن الطابور الصباحي وبداية الحصة الأولى، إضافة إلى غيابها أياماً متفرقة دون عذر مقبول، خاصة أيام الأحد والخميس. وقد انعكس ذلك على فقدها لعدد من الدروس والتقويمات، وتراجع مستواها في الرياضيات والعلوم.

المظاهر السلوكية الملاحظة:

- التأخر الصباحي 11 مرة خلال شهر واحد بمعدل 15 إلى 30 دقيقة.
- الغياب 5 أيام متفرقة بدون عذر، ثلاثة منها يومي أحد وخميس.
- الحضور بمظهر يدل على قلة النوم والإرهاق.
- فقد عدد من التقويمات القصيرة وعدم تسليم بعض المهام.
- تبريرات متكررة: (ما صحيت)، (ما فيه أحد يوصلني).

3 أدوات التشخيص وجمع المعلومات

الأداة	الإجراء المنفّذ	أبرز النتائج
سجلات الحضور	تحليل بيانات نور وسجل التأخر لشهرين	نمط واضح في بداية ونهاية الأسبوع
مقابلة الطالبة	جلستان فرديتان	سهر على الجوال، ومساعدتها في رعاية إخوتها صباحاً
مقابلة ولية الأمر	لقاء حضوري	ظروف عمل الأب ومواعيد المواصلات غير منتظمة
استبانة العادات اليومية	جدول نوم وأنشطة لأسبوع تعبّئه الطالبة	متوسط النوم 6 ساعات فقط

الأداة	الإجراء المنفّذ	أبرز النتائج
تقارير المعلمات	استمارة رصد	فاقد في دروس الحصة الأولى بشكل خاص
السجل الصحي	مراجعة مع المرشدة الصحية	لا توجد أعذار صحية مسجلة

4 تحليل أسباب المشكلة

عوامل ذاتية

- السهر واضطراب مواعيد النوم.
- ضعف الإحساس بأهمية الانضباط وأثر الغياب.
- قلة الدافعية للحصص الأولى.

عوامل أسرية

- عدم انتظام وسيلة النقل.
- تحميلها أعباء رعاية الإخوة الصغار صباحاً.
- تساهل الأسرة في الغياب بنهاية الأسبوع.

عوامل مدرسية

- تأخر التواصل مع الأسرة في بداية تكرار التأخر.
- غياب التحفيز للانضباط وقلة الأنشطة الجاذبة صباحاً.
- عدم ربط الحضور بنتائج التحصيل أمام الطالبة.

5 التشخيص

العبارة التشخيصية

تعاني الطالبة (ه) من تأخر صباحي وغياب متكرر بدون عذر ناتج عن اضطراب نمط النوم والسهر على الأجهزة، وعدم انتظام وسيلة النقل، وتحميلها أعباء أسرية صباحية، مع تساهل أسري في الغياب وضعف التدخل المدرسي المبكر.

6 الخطة العلاجية

الهدف	الإجراءات	المسؤول	المدة	مؤشر النجاح
التدخل الإداري المتدرج	تطبيق إجراءات قواعد السلوك والمواظبة بالتدرج، واستدعاء ولي الأمر وتوقيع تعهد	وكيلة شؤون الطالبات	فوري	توقيع التعهد والتزام الأسرة
تنظيم النوم والاستيقاظ	جدول نوم أسبوعي بالاتفاق مع الطالبة والأسرة، وإيقاف الجوال قبل النوم بساعة	الموجهة الطلابية	4 أسابيع	ارتفاع متوسط النوم إلى 8 ساعات
حل مشكلة النقل	التنسيق مع الأسرة لبديل نقل ثابت أو ضمها لمجموعة نقل منتظمة	الوكيلة وولي الأمر	أسبوعان	وصولها قبل الطابور 4 أيام من 5
التحفيز الإيجابي	بطاقة (منضبطة الأسبوع) ولوحة حضور شهرية ومكافأة للحضور التام	رائدة الفصل	فصل دراسي	حضور تام لمدة 4 أسابيع متتالية
تعويض الفاقد	خطة تعويضية لدروس الحصة الأولى في الرياضيات والعلوم	معلمات المواد	4 أسابيع	اجتياز التقويمات التعويضية

الهدف	الإجراءات	المسؤول	المدة	مؤشر النجاح
تعزيز المسؤولية	تكليفها بمهمة صباحية (مساعدة في الطابور أو الإذاعة) تربطها بالحضور المبكر	مسؤولة النشاط	فصل دراسي	التزامها بالمهمة دون تأخر

7 المتابعة والتقويم

الفترة	ما تم تنفيذه	النتيجة المتحققة
الأسبوع 1 إلى 2	استدعاء ولي الأمر وحل مشكلة النقل	انخفاض التأخر من 3 إلى مرة واحدة أسبوعياً
الأسبوع 3 إلى 4	جدول النوم والمهمة الصباحية	لم تُسجل حالات غياب بدون عذر
الأسبوع 5 إلى 6	التحفيز وخطة تعويض الفاقد	اجتياز تقويمين تعويضيين
الأسبوع 7 إلى 8	تقويم شامل	حضور تام لأربعة أسابيع وحصولها على شهادة الانضباط

8 التوصيات

- الرصد اليومي للتأخر والغياب والتواصل مع الأسرة من أول تكرار لا من تراكمه.
- إطلاق مبادرة مدرسية للانضباط تتضمن تكريماً شهرياً للفصل الأعلى حضوراً.
- تنفيذ لقاء توعوي لأولياء الأمور حول أثر الغياب وأهمية النوم على التحصيل.
- جعل الحصة الأولى والطابور أكثر جاذبية بأنشطة قصيرة محفزة.
- تحليل بيانات الغياب شهرياً لاكتشاف الأنماط (أيام بعينها) ومعالجتها جماعياً.

الموجهة الطلابية
هند العتيبي

رائدة الفصل
أبرار الطلحي

مديرة المدرسة
ناديه عوض الصخيري

البحث التشخيصي – الحالة السادسة

6 تشتت الانتباه وفرط الحركة

المجال: **سلوكي – تعليمي** | العام الدراسي: **1448هـ** | مستوى السرية: **سري**

1 بيانات الحالة

الاسم الرمزي **الطالب (ف)**	الصف **الأول الابتدائي (الطفولة المبكرة)**	العمر **6 سنوات ونصف**
ترتيبه بين إخوته **الثاني من ثلاثة**	جهة الإحالة **معلمة الصف**	تاريخ الإحالة **الأسبوع السادس من الفصل الدراسي الأول 1448هـ**

2 وصف المشكلة

تشير معلمة الصف إلى أن الطالب (ف) لا يستطيع البقاء في مقعده أكثر من دقائق معدودة، ويتنقل في الفصل ويقاطع المعلمة وزملاءه باستمرار، ولا يكمل المهام المطلوبة منه، وينسى أدواته ويفقدها بشكل يومي، رغم أنه ذكي ويستوعب بسرعة عندما يُعطى انتباهه. وتؤكد الأسرة ظهور هذه السمات في البيت منذ مرحلة الروضة.

المظاهر السلوكية الملاحظة:

- مغادرة المقعد بمعدل 8 إلى 10 مرات في الحصة الواحدة.
- عدم القدرة على التركيز في المهمة أكثر من 3 إلى 5 دقائق.
- المقاطعة المستمرة والإجابة قبل اكتمال السؤال.
- عدم إكمال الأعمال الكتابية ونسيان الأدوات وفقدها يومياً.
- اندفاعية في الحركة أدت لحوادث بسيطة مع زملائه دون قصد الإيذاء.

3 أدوات التشخيص وجمع المعلومات

الأداة	الإجراء المنفّذ	أبرز النتائج
الملاحظة المنظمة	رصد تكرار مغادرة المقعد ومدة التركيز في 10 حصص	متوسط 9 مرات مغادرة، وتركيز 4 دقائق
قائمة تقدير السلوك	قائمة رصد للسمات تعبّئها المعلمة والأسرة (للاسترشاد لا للتشخيص)	تطابق السمات في البيئتين المدرسية والمنزلية
مقابلة ولية الأمر	لقاء حضوري	السمات واضحة منذ عمر 4 سنوات، وتأخر في النوم
ملاحظة الأداء	مقارنة أداء المهام القصيرة بالطويلة	إنجاز ممتاز في المهام القصيرة المصحوبة بحركة

الأداة	الإجراء المنفّذ	أبرز النتائج
الملف الصحي	مراجعة مع المرشدة الصحية	لا توجد ملاحظات مسجلة، والسمع والنظر سليمان
تقارير المعلمات	استمارة رصد من 3 معلمات	النمط ذاته في جميع الحصص

4 تحليل أسباب المشكلة

عوامل ذاتية

- سمات اندفاعية وحركية عالية ظاهرة منذ سن مبكرة.
- صعوبة تنظيم الذات والانتباه المستمر.
- احتمال وجود عامل نمائي يستلزم تقييماً متخصصاً.

عوامل أسرية

- عدم انتظام مواعيد النوم.
- الاستخدام المطوّل للأجهزة ذات المثيرات السريعة.
- عدم وجود روتين منزلي ثابت للمهام.

عوامل مدرسية

- طول المهام الصفية مقارنة بقدرته على التركيز.
- جلوسه في موقع كثير المشتتات قرب النافذة والباب.
- قلة الفواصل الحركية المنظمة أثناء الحصة.

5 التشخيص

العبارة التشخيصية

تُظهر المعطيات لدى الطالب (ف) مؤشرات تشتت انتباه وفرط حركة واندفاعية تظهر في أكثر من بيئة ومنذ عمر مبكر، مما يستدعي الإحالة لجهة طبية متخصصة لتقييمها؛ والدور المدرسي هنا تربوي داعم ولا يُعد تشخيصاً طبياً.

6 الخطة العلاجية

الهدف	الإجراءات	المسؤول	المدة	مؤشر النجاح
الإحالة للتقييم المتخصص	توجيه الأسرة بخطاب رسمي لعرض الطفل على طبيب أطفال نمائي / مختص بموافقتها	الموجهة الطلابية	أسبوعان	استلام تقرير الجهة المختصة
تهيئة البيئة الصفية	إجلاسه قرب المعلمة بعيداً عن المشتتات، وتقليل المثيرات على طاولته	معلمة الصف	فوري	انخفاض مرات مغادرة المقعد بنسبة 30%
تجزئة المهام	تقسيم المهمة إلى أجزاء قصيرة (5 دقائق) مع مؤقت مرئي وتعزيز فوري بعد كل جزء	معلمات الفصل	مستمر	إكمال 70% من المهام الصفية
فواصل حركية منظمة	تكليفه بمهام حركية مفيدة (توزيع، مسح السبورة) وفاصل حركي قصير كل 15 دقيقة	معلمة الصف	مستمر	انخفاض المقاطعة والتنقل غير المنظم
نظام تعزيز رمزي	بطاقة نجوم يومية لسلوكين محددين فقط (البقاء في المقعد – رفع اليد) تُستبدل بمكافأة	معلمة الصف	8 أسابيع	تحقيق السلوكين في 4 حصص يومياً

الهدف	الإجراءات	المسؤول	المدة	مؤشر النجاح
الشراكة الأسرية	روتين منزلي ثابت للنوم والواجب، وتقليل الأجهزة، ودفتر تواصل يومي	الموجهة وولية الأمر	مستمر	انتظام دفتر التواصل بنسبة 80%

7 المتابعة والتقويم

الفترة	ما تم تنفيذه	النتيجة المتحققة
الأسبوع 1 إلى 2	الإحالة وتهيئة البيئة الصفية	انخفاض مغادرة المقعد إلى 6 مرات في الحصة
الأسبوع 3 إلى 4	تجزئة المهام والفواصل الحركية	ارتفاع إنجاز المهام إلى 55%
الأسبوع 5 إلى 6	التعزيز الرمزي ومتابعة الأسرة	انخفاض المقاطعة بشكل واضح
الأسبوع 7 إلى 8	التقويم ومراجعة تقرير الجهة المختصة	إنجاز 70% من المهام وتعديل الخطة وفق توصيات المختص

8 التوصيات

- تدريب المعلمات على استراتيجيات إدارة الصف مع المتعلمين كثيري الحركة والتشتت.
- عدم وصف أي متعلم بـ(فرط الحركة) أمام الآخرين أو في المراسلات قبل صدور تقرير طبي.
- توفير أدوات بسيطة مساعدة (مؤقت مرئي، بطاقات خطوات، ركن هادئ).
- التنسيق مع برنامج صعوبات التعلم والتربية الخاصة عند ثبوت الحاجة.
- إعداد خطة تربوية فردية بعد استلام تقرير الجهة المختصة وتحديثها كل فصل.

الموجهة الطلابية
هند العتيبي

رائدة الفصل
نجود الزهراني

مديرة المدرسة
ناديه عوض الصخيري

البحث التشخيصي – الحالة السابعة

7 الإفراط في استخدام الأجهزة الذكية

المجال: **سلوكي – صحي** | العام الدراسي: **1448هـ** | مستوى السرية: **سري**

1 بيانات الحالة

الاسم الرمزي	الصف	العمر
الطالبة (ج)	**الخامس الابتدائي**	**10 سنوات**
ترتيبها بين إخوتها	جهة الإحالة	تاريخ الإحالة
الثالثة من أربعة	**معلمة العلوم ورائدة الفصل**	**الأسبوع السابع من الفصل الدراسي الأول 1448هـ**

2 وصف المشكلة

لاحظت المعلمات أن الطالبة (ج) تحضر مرهقة وتغفو أحياناً في الحصص، وأن حديثها مع زميلاتها يدور غالباً حول الألعاب الإلكترونية ومقاطع المنصات، وتراجع مستواها وتأخرت في تسليم الواجبات. وبيّنت المقابلة أنها تمتلك جهازاً خاصاً وتستخدمه لساعات طويلة يومياً، بما في ذلك ساعات متأخرة من الليل، مع ضعف في الرقابة على المحتوى.

المظاهر السلوكية الملاحظة:

- استخدام الجهاز بمعدل 6 إلى 7 ساعات يومياً، وحتى منتصف الليل أحياناً.
- النعاس والإرهاق وضعف التركيز في الحصص الأولى.
- تراجع المعدل وتأخر تسليم الواجبات والمشاريع.
- الانفعال الشديد عند الحديث عن تقليل وقت الجهاز.
- ضعف المشاركة في الأنشطة الحركية والتفاعل المباشر مع الزميلات.

3 أدوات التشخيص وجمع المعلومات

الأداة	الإجراء المنفّذ	أبرز النتائج
مقابلة الطالبة	جلستان فرديتان	تستخدم الجهاز للألعاب والمقاطع وتشعر بالملل بدونه
مقابلة ولية الأمر	لقاء حضوري	لا توجد ضوابط زمنية، والجهاز معها في غرفة النوم
استبانة العادات الرقمية	جدول استخدام يومي لأسبوع تعبّئه الطالبة مع الأسرة	متوسط 6.5 ساعات يومياً
تقارير المعلمات	استمارة رصد من 4 معلمات	إرهاق وتراجع في الواجبات والمشاريع

الأداة	الإجراء المنفّذ	أبرز النتائج
الملف الصحي	مراجعة مع المرشدة الصحية	شكوى من إجهاد العين وصداع متكرر
السجلات المدرسية	مقارنة الدرجات بالعام الماضي	انخفاض المعدل في 4 مواد

4 تحليل أسباب المشكلة

عوامل ذاتية	عوامل أسرية	عوامل مدرسية
• الانجذاب للمكافأة السريعة في الألعاب والمقاطع. • قلة الهوايات والأنشطة البديلة. • ضعف مهارة تنظيم الوقت.	• امتلاك جهاز خاص دون ضوابط زمنية أو رقابة على المحتوى. • وجود الجهاز في غرفة النوم. • انشغال الأسرة واستخدام الجهاز وسيلة إلهاء.	• قلة برامج التوعية بالمواطنة الرقمية للمرحلة. • قلة الأنشطة اللاصفية الجاذبة. • عدم التواصل المبكر مع الأسرة عند ظهور الإرهاق.

5 التشخيص

العبارة التشخيصية

تعاني الطالبة (ج) من إفراط في استخدام الأجهزة الذكية أثّر على نومها وصحتها وتحصيلها وعلاقاتها الاجتماعية، ناتج عن غياب الضوابط الأسرية وقلة البدائل والأنشطة الهادفة وضعف مهارات تنظيم الوقت.

6 الخطة العلاجية

الهدف	الإجراءات	المسؤول	المدة	مؤشر النجاح
الاتفاق الأسري الرقمي	إعداد ميثاق استخدام بين الطالبة والأسرة: ساعتان يومياً كحد أعلى، ولا جهاز في غرفة النوم	الموجهة وولية الأمر	الأسبوع الأول	التزام الأسرة بالميثاق الموقّع

الهدف	الإجراءات	المسؤول	المدة	مؤشر النجاح
ضبط المحتوى والوقت	تفعيل أدوات الرقابة الأبوية ومؤقت الاستخدام بإرشاد الأسرة	ولية الأمر	أسبوعان	انخفاض الاستخدام إلى 3 ساعات ثم ساعتين
بدائل جاذبة	إشراكها في نادي العلوم أو الفن أو القراءة، واكتشاف هواية حقيقية	مسؤولة النشاط	فصل دراسي	انتظامها في نشاط أسبوعي
التوعية الصحية	جلسة مع المرشدة الصحية عن النوم وصحة العين وقاعدة 20–20–20	المرشدة الصحية	جلستان	تحسّن الإرهاق والصداع
مهارات تنظيم الوقت	تدريبها على جدول يومي متوازن (دراسة – نشاط – أسرة – جهاز)	الموجهة الطلابية	4 جلسات	التزامها بالجدول 5 أيام أسبوعياً
استعادة التحصيل	خطة لتسليم الواجبات المتأخرة ومتابعة أسبوعية للمشاريع	رائدة الفصل والمعلمات	6 أسابيع	تسليم جميع الواجبات في وقتها

7 المتابعة والتقويم

الفترة	ما تم تنفيذه	النتيجة المتحققة
الأسبوع 1 إلى 2	توقيع الميثاق وضبط الأدوات	انخفاض الاستخدام إلى 4 ساعات يومياً
الأسبوع 3 إلى 4	التوعية الصحية والنادي	اختفاء النعاس في الحصص الأولى
الأسبوع 5 إلى 6	تنظيم الوقت واستعادة التحصيل	تسليم الواجبات في وقتها
الأسبوع 7 إلى 8	تقويم شامل ولقاء الأسرة	الالتزام بساعتين يومياً وتحسن المعدل

8 التوصيات

- تنفيذ برنامج سنوي للمواطنة الرقمية والاستخدام الآمن للأجهزة لطالبات المرحلة.
- إصدار دليل مختصر لأولياء الأمور عن الضوابط الرقمية المناسبة لكل عمر.
- التوسع في الأندية والأنشطة اللاصفية بوصفها بدائل جاذبة.
- رصد مؤشرات الإرهاق والنعاس صباحاً والتواصل المبكر مع الأسرة.
- تضمين موضوع التوازن الرقمي في حصص النشاط والإذاعة المدرسية.

الموجهة الطلابية
هند العتيبي

رائدة الفصل
نجلاء الصخيري

مديرة المدرسة
ناديه عوض الصخيري

الخاتمة والتوصيات العامة

كشفت البحوث التشخيصية السبعة الواردة في هذا الملف أن مشكلات المتعلمين في المرحلة الابتدائية نادراً ما تنشأ عن سبب واحد، بل تتشابك فيها العوامل الذاتية والأسرية والمدرسية، وأن المعالجة الفاعلة تبدأ بالفهم العميق قبل التدخل، وتقوم على الشراكة الحقيقية بين المدرسة والأسرة، وتعتمد على أهداف قابلة للقياس ومتابعة منتظمة.

كما أكدت النتائج أن الاكتشاف المبكر والتواصل السريع مع ولي الأمر يختصران كثيراً من الجهد والوقت، وأن البيئة الصفية الآمنة والمتفهمة عامل مشترك في نجاح جميع الخطط العلاجية.

التوصيات العامة على مستوى المدرسة

المحور	التوصية
الاكتشاف المبكر	تطبيق الاختبارات التشخيصية واستمارات الرصد في الأسابيع الأولى من كل فصل دراسي.
الشراكة الأسرية	تفعيل قنوات تواصل منتظمة مع الأسر وإلزامية الإبلاغ عن الظروف الطارئة بسرية.
التنمية المهنية	تدريب المعلمات على مهارات اكتشاف الحالات والتعامل التربوي معها.
البرامج الوقائية	تنفيذ برامج جماعية سنوية: مكافحة التنمر، المواطنة الرقمية، الانضباط، الدعم النفسي.
التوثيق والسرية	توحيد نماذج دراسة الحالة وحفظها في ملف سري لدى الموجهة الطلابية.
التكامل مع الجهات المساندة	الإحالة المنظمة للجهات الصحية والنفسية والتربية الخاصة عند الحاجة.

المرجعية واعتماد الملف

المرجعية

- قواعد تنظيم السلوك والمواظبة لطلاب وطالبات التعليم العام – وزارة التعليم.
- الأدلة الإجرائية للتوجيه والإرشاد الطلابي في مدارس التعليم العام – وزارة التعليم.
- أدلة الصحة المدرسية والبرامج الوقائية – وزارة التعليم.
- مراجع علم النفس التربوي ومنهجية دراسة الحالة في الإرشاد المدرسي.

اعتماد الملف

اطّلعت لجنة التوجيه والإرشاد بالمدرسة على البحوث التشخيصية الواردة في هذا الملف، وأقرّت منهجيتها وخططها العلاجية، وأوصت بتعميم ما ورد فيها من إجراءات وقائية على منسوبات المدرسة، مع الالتزام التام بسرية معلومات الحالات.

م	الاسم	الصفة	التوقيع
1	ناديه عوض الصخيري	مديرة المدرسة – رئيسة اللجنة	
2		وكيلة الشؤون التعليمية	
3		وكيلة شؤون الطالبات	
4	هند العتيبي	الموجهة الطلابية – مقررة اللجنة	
5		المرشدة الصحية	
6		رائدة نشاط	

مديرة المدرسة

ناديه عوض الصخيري

الختم الرسمي

المملكة العربية السعودية – وزارة التعليم
الابتدائية السابعة والستون بالطائف بنات
الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف